TUBE DIGESTIF · DI-05

Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II)

ESGAR 2026 part II (Eur Radiol)
restaging · ycT, ycMRF, ycEMVI, ycN, watch-and-wait

Principe ESGAR 2026 (partie II) — La réponse s'évalue en **T2 + diffusion + endoscopie**, et se classe en **trois catégories liées à la prise en charge** ; l'objectif premier est d'identifier les candidats à la **préservation d'organe** (watch-and-wait ou traitement local).

PROTOCOLE DE RÉÉVALUATION

Identique au bilan initial

- Mêmes séquences que la partie I (T2 haute résolution ≤ 3 mm, plans obliques perpendiculaires, diffusion, grand champ)
- **Micro-lavement recommandé** (consensus à 85 %) : moins d'artefacts de susceptibilité en diffusion
- Évaluation intégrée **T2 + DWI + endoscopie** — jamais l'IRM seule

Timing

- IRM et endoscopie après la fin du traitement néoadjuvant (chimioradiothérapie : habituellement 6–12 semaines)
- **Quasi-RC ou doute** : deuxième IRM + endoscopie après **6–12 semaines supplémentaires** avant de conclure (« test du temps »)
- La réponse en IRM et en endoscopie **retarde sur la réponse histologique** : des anomalies persistent souvent sans tumeur viable

CATÉGORIE DE RÉPONSE · TROIS GROUPES

Classer chaque patient

RC / quasi-RC	candidat watch-and-wait ou traitement local
Résidu minime	potentiellement éligible à un traitement local
Résidu majeur	résection radicale (planifier les marges)

Mentionner explicitement dans la conclusion les patients potentiellement éligibles à la préservation d'organe.

Règles ycT

- (Quasi-)RC : **ne pas attribuer de ycT** (nouveauté vs 2018) — précision faible, risque d'exclure à tort de la préservation d'organe
- Tumeur résiduelle : ycT mesuré sur **toute la zone de fibrose** (hauteur et longueur comprises)
- La DWI sert uniquement à distinguer **ycT0 vs ycT+**, pas à préciser le ycT

T2 + DIFFUSION · PIÈGES DE LECTURE

Faux positifs en diffusion

- **T2 shine-through**, artefacts de susceptibilité
- Signal non tumoral : **inflammation, ulcération**
- Confronter **ADC + forme du signal + T2** : signal intermédiaire résiduel suspect = tumoral ; fibrose en hyposignal T2

mrTRG

- Estimation globale de la réponse (bonne vs mauvaise)
- **Sensibilité insuffisante** pour identifier les RC pathologiques → **pas de ligne séparée** dans le compte rendu ESGAR 2026
- Combiner résidu T2 + fibrose + restriction, quel que soit le traitement néoadjuvant

YCMRF · YCEMVI

ycMRF

- Même seuil qu'au bilan initial : **marge ≤ 1 mm = ycMRF+** (tumeur, ycEMVI, dépôts ou ganglions irréguliers suspects)
- **Fibrose massive** pénétrant la MRF : souvent MRF+ en histologie
- **Fines brides fibreuses** vers la MRF : habituellement MRF non atteinte
- La **diffusion améliore la sensibilité** (nouveauté vs 2018)

ycEMVI

- Même grading qu'au bilan initial : **grades 3–4 = ycEMVI+**
- ycEMVI+ = **survie sans récidive réduite**
- La diffusion améliore la spécificité ; évaluer aussi les dépôts le long des veines

RÉPONSE GANGLIONNAIRE (YCN)

Mésorectaux

- Seuil **5 mm** maintenu, mais **prudence si RC luminale** : ypT0 → **ypN+ dans ~7 % seulement** ; regrowth ganglionnaire isolé : 3–6 % des reprises locales
- Ganglions « borderline » (~5 mm) : **IRM de contrôle à 6–12 semaines** avant d'exclure la préservation d'organe
- Dépôts tumoraux : restent classés **ycN** ; rapporter l'évolution de taille et d'aspect
- Décision toujours en **RCP**

Latéraux

- **Aucun seuil validé** en réévaluation (le ≥ 7 mm du bilan initial ne s'applique pas)
- Trois scénarios : **diminution** (le plus fréquent) · **disparition** (stérilisation probable) · **stabilité ou progression** (LLND à discuter en RCP)
- Toujours rapporter la réponse des ganglions latéraux initialement suspects

TUMEURS MUCINEUSES

Mucineux primitif

- Réponse limitée à la (chimio)radiothérapie, **peu de fibrose**, diffusion peu utile

Dégénérescence mucineuse

- Mucine acellulaire apparue après traitement d'une tumeur solide : **à mentionner** dans le compte rendu

- RC plus rare que pour les tumeurs solides ; **watch-and-wait exceptionnel** → à discuter systématiquement en RCP
- **Impossible** de distinguer mucine acellulaire et mucine contenant des cellules viables

- **Ne pas l'interpréter comme une mauvaise réponse** (pas d'association avec réponse, récidive ou survie)
- Ne contre-indique pas le watch-and-wait si l'endoscopie montre une RC typique

PERSPECTIVES

- **OPERA** (tumeurs précoces ≤ 5 cm, cN0-1 < 8 mm) : boost externe ou curiethérapie de contact → RC **81 % à 3 ans**
- **TNT** (chimio)radiothérapie + 4–6 cures de chimiothérapie, pour les très haut risque (cT4b, EMVI+, latéraux, dépôts, MRF+) : plus de préservation d'organe, moins de métastases à distance
- **Immunothérapie** : réponses exceptionnelles en cas de tumeur MMR-déficiente ; critères de réponse propres à chaque stratégie à venir

Rectum traité · réponse (ESGAR 2026 II) (suite)

POUR ALLER PLUS LOIN · CLIQUER OU SCANNER LE QR CODE

ESGAR 2026 partie II – restaging
Eur Radiol · texte intégral
link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-122

PubMed – ESGAR part II
PubMed 41609771
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/

IRM rectale : démarche
Radiopaedia · lecture pas à pas
radiopaedia.org/articles/rectal-mri-an-approach

EMVI
Radiopaedia · grades
radiopaedia.org/articles/extramural-vascular-inv

Watch-and-wait : démarche
PMC · revue pratique
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37055617/

Rectal cancer lexicon 2023
SAR · lexique révisé
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37122059/

Sources : ESGAR 2026 – Restaging and response evaluation, part II – link.springer.com/article/10.1007/s00330-025-12275-9 · PubMed – ESGAR part II (2026) – pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41609771/